

这里集中回答关于我的文章的若干问题。读者如果能在阅读这些文章之前了解这些问题，可以少很多不必要的麻烦和误会。

Q：你的创作动机是什么？

A：我创作这些文章的初衷，一是为了自我总结，二是为了分享给有缘分的人。也就是说，我更希望自己被看成一位**分享者**而非**施助者**。我希望读者能感受到，支持他们自救的是这个社会，我只是其间一位发出声音的人。如果我的文章让你感受到了这世界的爱和阳光，那么我希望你能把同样的爱和阳光回馈给这个世界。我无意于给任何人施加精神压力，也不愿看到有读者因为感到我是一位“不称职的施助者”而气急败坏。

Q：自助文章的受众是谁？

A：这些文章的受众至少要**同时满足**以下几点：

1. 虽然感到受伤，但在内心深处热爱家庭，热爱世界，希望被接纳。
2. 对自己的智力与才能有一定自信。可以理解成一般人（包括求助于治疗师的人）脑子里只需要跑一个系统，而自救者需要在原本的系统里再开一个虚拟机，因此需要超常的承载能力和处理能力。
3. 深刻感受到自己在适应社会方面的严重困难，而这种困难并不能简单地用性格、经验或者智商问题来解释。
4. 存在各种心理障碍表现，但又未达到临床诊断的阈限。
5. **无人格障碍史或重性精神障碍史。**
6. 不满足于传统的基于社会关系范式或病理学范式的调节手段。
7. 不屑于用神经多样性范式理解自身问题。
8. 已成年且拥有基本的生活能力。
9. 追求超越创伤而非与创伤共存。
10. 熟悉认知行为疗法，但效果已进入平台期，很难再进步。

如果非要用病理学范式的做法给符合上述条件的人贴标签的话，可能会涉及 CPTSD、ADHD、ASD 等标签。这些条件看似苛刻，实际是自助的基本要求，缺一不可。

自救动机在很大程度上决定了自救之路能走多远。如果你能认识到**自己在根本上被爱着，但自己却因为各种难以言说的局限无法去爱别人**，我的文字或许会有所帮助。如果出于消极的动机，比如“想让坏人害怕自己”“想要为过去的自己复仇”“想让人们认可我身上的另类标签”，“想在纯理论层面实现自愈”，那么请恕我无能为力。

针对性与选择性是一体两面的关系。一篇文章越容易引起特定人群的共鸣，就越容易引起另一些人的不适甚至反感。因此，如果我的文章引起了您的不适，很可能只是意味着我们没有缘分而已。您大可以将其抛诸脑后，不必为此动肝火，这不值得。

Q：CPTSD 和人格障碍、重性精神障碍是什么关系？

A：心理问题和精神问题是不同的概念。我的讨论只涉及一般意义的心理问题，而人格障碍、重性精神障碍（俗称“精神病”）属于精神问题范畴。如果您的问题涉及人格障碍或重性精神障碍，建议寻找专业帮助。**CPTSD 不是精神病，我对精神病相关话题不感兴趣。**

CPTSD 虽然不是精神病，但这种命名方式本身立足于病理学框架，“应激障碍”更是典型的临床概念，具有鲜明的病理学色彩。为了弱化这种色彩，我会像一般心理博主一样，用心理创伤（trauma）、长期创伤、慢性创伤、严重创伤、复杂性创伤（complex trauma）、适应不良这些更具体的说法取代“应激障碍”，用创伤幸存者（survivor）、受困者或者更口语化的“心态崩溃者”这些中性称呼取代“CPTSD 患者”。

Q：CPTSD 和抑郁症、强迫症有什么关系？

A：CPTSD 所涉及的抑郁、焦虑、强迫等概念指的是一系列**阈下状态**，与典型意义的抑郁症焦虑症强迫症不是一回事。如果你的问题涉及后者，建议线下寻找专业帮助。

Q：为什么你如此反感倾诉？

A：自救需要蓄力，而倾诉会偷偷撕开一条能量的缺口。有了倾诉这么一种简单地释放能量的方式，能量就无法积蓄到自救所需要的水平了。倾诉和自救根本对立，一个人不可能一边保留倾诉的习惯，一边彻底处理自己的创伤。能否在正视自身沟通欲的同时拒绝用倾诉安抚它、释放它，是区分“超越派”和“共存派”最简单可靠的指标。两派人完全尿不到一个壶里。

超越创伤一方面需要充分接纳自己和他人的实际状态，不再基于某种幻想的“理想状态”来批判自己和他人，另一方面需要有与自己内心的困境斗争到底的精神。这既不是摆烂，也不是麻木，更不是跟自己较劲。个中奥妙需要灵性才能体会，能转过这个弯的人自然就是“超越派”。

Q：这样严格的筛选是否会导致文章受众过窄？

A：我的文章受众确实很窄，但这不是由我的筛选造成的。大多数潜在受众很难意识到自己需要这些东西，而意识到自己需要这些东西的人有很多已经不再适用这些东西了。这种局面是心理创伤的科普严重缺位、大众对心理创伤的知识严重匮乏所造成的。我曾经在某书上分享过自己对创伤的一些理解，然后发现对这些文字最感兴趣的并不是最需要这类知识的**创伤幸存者**，而是各类**精神病患者**。精神病患者当然普遍存在各类创伤，但这些创伤已经不是他们的首要问题了，我也没有能力和他们进行有益的沟通。（心理问题和精神问题存在一定相似性，我不否认存在误诊的情形。但现代精神病学早已超越罗森汉实验的时代了，我们必须对临床诊断保持敬畏。）

很多人倾向于避开直面创伤的压力，通过自我孤立和玄学讨论寻求安慰，导致精神日渐颓唐，神经质倾向越来越重，直到被精神科医生贴上各种人格障碍甚至重性精神障碍的标签，才认识到自己的创伤。这时候再谈论自救，已经没有实际意义了。有的精神病人试图以“幸存者”甚至“超越者”的身份接近我，但用不了多久，他们身上那种令人后背发凉的“伪人感”就会暴露。我只是一个普通人，没有理由置身如此险境。

网上所谓幸存者，绝大多数都是各种精神病人。如果一个人以 CPTSD 幸存者自居，

那么 CPTSD 很可能只是他身上最小的问题。因为创伤远比精神病好听得多了，也比精神病更安全、更令人同情，CPTSD 也就成了各种精神病的遮羞布。正是这些人的抽象言行造成了心理创伤的污名化。**如果真正的幸存者不为自己发声，那么创伤的话语权就会被这些人彻底占据。**

Q: CPTSD 和 ADHD 是什么关系？

A: 老虎 和 大尖牙 的关系。

Q: CPTSD 和自闭症谱系障碍是什么关系？

A: 老虎幼崽和小型猫科动物的关系。

Q: CPTSD、阿斯伯格综合征和自闭症是什么关系？

A: 猎手们抓住了一只小动物。有的人说是猫，有的人说是小老虎，有的人说咱们暂且叫个新名字吧。身后的孩子们听不下去了，说你们吵完了没有？我快饿死了。

Q: CPTSD 和 PTSD 是什么关系？

A: PTSD 像刀砍，CPTSD 像针扎。如果说 PTSD 是致命的一刀，那 CPTSD 就是虽不致命却无法逃脱、像秋雨一般连绵不绝的一针又一针。其中很多针细到几乎看不见，但只要不拔出来，伤就会一直存在。与 PTSD 相比，CPTSD 涉及的创伤源往往相对温和，主体更容易承受在处理创伤过程中激起的各种痛苦情绪，这为自救提供了一定空间。主体作为亲历者，在梳理复杂感受方面也有特殊的资源优势。从心理学角度来说，CPTSD 远比 PTSD 复杂，但是从自救角度来说，CPTSD 反而比 PTSD 容易处理。这也是我更倾向于将 CPTSD 译作“复杂性创伤后压力综合征”而非“复杂性创伤后应激障碍”的原因。

Q: 这些比喻太粗糙了，能不能用科学严谨的语言表达清楚？

A: 这就跟说创伤后应激障碍是“吓坏了”一样，对于没兴趣了解相关专业知识的人来说，这是一种敷衍，对于不满相关专业知识的人来说，这是一种恰到好处的模糊。**模糊是该领域的现状。**正如沃伦·巴菲特所言，**模糊的正确胜过精确的错误。**如果一切都像小学算术那样清晰，问题根本就不会存在。了解专业知识需要付出专业的投入，这不是自助读物的责任。

心理创伤好比驾驶事故，自救好比重学驾驶。自救知识不是数学知识，自救不是解数学题。分析的前提是体会。体会不到，分析越多，离问题的解决就越远。

Q：可你有时候又很喜欢咬文嚼字，为什么？

A：因为我发现很多人太容易被各种虚头巴脑的名词困住了。名词不是食物也不是房子，它们只是为了便于认知过程的缓冲和推进所选取的休息点、支撑点而已。例如说“躺平”很多人不高兴，说“蛰伏”他们立刻又高兴了。到底是躺平还是蛰伏，自己心里当真没数？说“弱者”很多人不高兴，说“倒霉催的”这些人就满意了。难道瞧不上弱者的人能瞧得上晦气的人？说创伤导致 ASD 很多人不高兴，说 ASD 导致创伤这些人就满意了。有没有可能二者本质上就是一回事？麻绳专挑细处断，噩运只找苦命人。人们到底是因为不幸而脆弱还是因为脆弱而不幸？这是先有鸡还是先有蛋一样的问题，纠结这些问题对自救没有任何帮助。我咬文嚼字，只是为了帮助那些有意愿的人更全面地了解自己的问题。越咬文嚼字，越说明这些概念本身其实没那么重要。例如我的文章中既用到了好奇-探索反应，又用到了观察者与当事者的分化。读者如果能够在应用层面理解它们，就会发现它们是一回事。观察者总是在好奇，当事者总是在探索。

自救者一定要远离空泛的抽象讨论，努力抓住那些最实际、最具“刚性”的事物，自救者最需要结交的朋友就是务实的人。

Q：为什么你讲的似乎和神经科学矛盾？

A：我从未觉得这里有什么矛盾。设想这里有一张照片，照片中的地面上有一个死人。你问别人他怎么死的？甲告诉你，他从楼上掉下来摔死的。乙告诉你，他是被情敌害死的。丙告诉你他内脏破裂、全身粉碎性骨折、失血过多而死。你是不是觉得他们互相矛盾呢？如果你这么觉得，那么你可能需要更加专业的帮助。

Q：心理自助和心理治疗最重要的区别是什么？

A：心理治疗强调以标准化方式快速切分责任，使治疗师和来访者能够在临时的治疗关系中快速进入角色。而自助则需要自己在长期生活的每一个细节中逐渐探索出自身问题的独特本质，调整自己的意识状态，调整自己对待自身本能的态度，让健康的行为模式自发涌现。智识相当于家长，身体相当于孩子。自己成为合格

的家长，孩子就会让你看到什么是生命力。父母教育孩子的过程也是孩子教育父母的过程。

自助不是自己充当自己的咨询师。它必须立足于当事者的现象学世界，充分考虑当事者的认知水平和生活阅历。**心理治疗理论很难直接用于自救，尤其是精神分析理论。**精神分析理论最大的问题在于它们完全服务于治疗师在治疗关系中的话语权（这在近些年兴起的主体间流派中有所收敛），很容易把当事者身上各种合理的适应行为都看成病态表现。很多人为了自救学习心理治疗，甚至成为了心理咨询师。他们的自我救赎尚未完成，就自以为可以帮助别人，最后往往害人害己。

自助更不是尝试用自己已经创伤化的行为模式去“自我矫正”，这就像妄想自己抓住自己的头发把自己拎起来一样不合逻辑。人坠下悬崖，一般都会摔死。假如没摔死，必然是因为他有意无意地抓住了第三方力量。自救者（幸存者）都是这些坠入悬崖却没摔死的人。自救理论就是帮他们看清楚这让自己免于毁灭的力量是什么，然后顺着它提供的线索，最终走出困境。

Q：为什么你的某些文章读起来令人不适？

A：如前文所述，如果我的某些文章读起来令您不适，肯定不是您的问题。当然，我也不会承认是我的问题。

作为回顾和总结，这些文章必然有一定居高临下的意味，如果读者把自己放在了被审视的位置，就很容易产生被藐视的感受。用一位朋友的说法，我是个高度自省、愿意在自己身上找问题的人，所以虽然我说的是自己的经验之谈，但是这种表述风格多少显得有点缺乏对创伤群体的深层悲悯（compassion），所以有的时候虽然理论可能有帮助，但是理解起来会产生歧义和抵抗，尤其是对本身就对自己有很多负面看法的人。

另外一方面，当前主流的自助读物普遍有强烈的“娘味”。所谓娘味，可以理解成“爹味”（权威自恋）的对立面。这些作品一般承担着为作者引流的任务，所以一定程度上需要牺牲干货，取悦读者，甚至让读者对自己产生依赖。我不靠这些东西吃饭，也就不需要刻意迁就谁。对我来说，自我剖析的过程就像是无麻醉的手术，自救的过程就像“驱鬼”和“除障”。魔鬼总是以诱人的面目和姿态盘

绕心间，和它们周旋需要很大的勇气、智慧和毅力。一段文字能否帮到自己，一定程度上取决于当它触及到自己的痛点时，自己是否还有意愿倾听它，这是人与文字的缘分。正因如此，我才强烈建议有条件的读者尽可能接受正规的心理治疗而不是自己闭门造车。自救是勇者的冒险。如果能力不足，自我剖析很容易变成自我否定，自救很容易沦为自恋，甚至造成二次创伤。如果能理解无麻醉手术的痛苦和傩舞面具的恐怖，或许就能理解我这种略带冷峻甚至恐怖色彩的文风背后的无奈。

Q：为什么自闭症的创伤后应激障碍假说这么不招人待见？

A：自闭症是早期崩溃（early breakdown，婴儿期甚至胚胎期的身心危机）所引起的创伤后应激障碍，创伤限制了主体的情感直觉，使他们只能依赖逻辑分析理解人际互动，自然无力应对复杂的人际关系。对很多一线工作者来说，这已是心照不宣的事实。虽然这一观点本身没有责怪任何人的意思，但自闭症儿童的养育者往往各种问题缠身，早期创伤（包括胚胎期创伤）方面的研究很容易刺激到他们。自闭症研究基金大多由自闭症患者的父母或相关组织筹集，该研究方向自然很难获得支持，导致自闭症至今仍是医学难题。考虑到自闭症的内涵存在很大模糊性，现在很多实干家正在尝试避开“自闭症谱系障碍”这一诊断，在“儿童创伤后应激障碍”等框架下开展研究，这样既能有针对性地帮助有需要的人，也能充分尊重那些神经多样性运动鼓吹者们的命运。

人们只会在刚刚陷入惊吓状态时有明显的初始反应，之后的创伤反应则会表现得比较隐蔽，特别是当成人不知道该关注哪些线索时更是无迹可寻。父母总是一边担心子女会遭遇最坏情况，一边又希望他们能有最好的结果。成人和儿童都处于极为激动的情绪状态，创伤的重要线索很容易被“一时冲动”掩盖。儿童创伤的识别也就成了一项复杂艰巨的任务。

Q：什么是自救者最重要的品质？

A：亲社会性是自救者最重要的品质。有亲社会性才会有胸襟，有胸襟才有足够的心理空间用来自救。不要对没有爱心或者没有公德心的人抱任何期望，各种强制措施才是他们的良药。

Q：你坚持无偿分享的动力是什么？

A：无偿分享干货的人很多都是图中这样（网图）：



人的生物性中固然有贪婪自私的一面，但分享和利他也是人类的本能，不懂得奉献的人必然会被空虚感包围。不过这话对于大多数人都是空话，因为普通人的认知早已被生活压力带来的恐惧所支配。儿童天生都懂得无私分享，只是在我们成长的过程中，随着积累的创伤越来越多，我们的心灵越来越封闭，精神越来越空虚，最后只能用庸俗的娱乐来麻痹自己方能逃避内心的痛苦。当我们像剥洋葱一

样一层层地突破了内心的恐惧之后，赤子之心就会回归，这时我们在一些方面会重新变得像孩子，仿佛自己获得了新生。

就我个人而言，我写这些东西最开始的目的就是交流。我冥冥之中感到，在地球上的一些角落里，有人正在干着和我一模一样的事情。交流过程中我自己曾得到很多启发，也着实领教了某多样性群体如邪教般的可怕以及个别半吊子从业者的狂妄。我本来想着写完了就放下了，没想到一直写不完。每次改完，放下一段时间以后就会发现一堆毛病，这让我仿佛背上了某种义务——要么别写，要么写好。经过了一年多的细节调整，这项工作已经基本完成。这不是说我已完全超越创伤，而是说我接下来的路已经不是心理治疗的叙事框架所能胜任的了，我对于围绕创伤的讨论已然失去兴趣。

为了避开 xx 多样性狂热分子的攻击，《复杂性创伤后压力综合征和阿斯伯格综合征的自助治疗：基于躯体体验的视角》已更名为《复杂性创伤后压力综合征的自我疗愈：基于躯体体验的视角》，内容不变。

Q：是否可以邀请你结伴互助？

A：很遗憾，不可以。

首先，我能分享的都已经在我文章里说完了。其次，**互信是互助的基石**。想要对话产生建设性，参与者就必须坚信彼此在根本上是正常人，相信双方可以共同为互动负责。在设定严格的治疗室中，互信的建立和维持尚且困难重重，以致对话常常陷入僵局，所谓结伴互助更是只能一次又一次地复制并强化自己那些病态的人际关系。

很多人有心理困扰，与人倾诉却得不到理解，因此感到更加孤独。这些人往往有一对情绪智力（emotional intelligence）极低的父母。在他们的成长过程中，每当自己遭遇心理危机和情绪困扰的时候，他们的父母不但无法帮助他们理解问题、疏导情绪，反而总是雪上加霜，导致他们的自我调节能力从未发展。当他们进入社会后，仍然像孩子那样执着于找到一个能听自己讲创伤故事的人，完全无法意识到日常对话中无所不在的“权力博弈”。一个人跟别人倾诉心理困扰，如果对方不是朋友，对方完全可以趁机在关系中抢占上位。如果对方是朋友（或者

潜在的朋友)，很可能会感到这个人是在用弱者身份向他施压，这会唤起他的防御。期待别人因为自己有心理问题而共情自己是很幼稚的想法。即使对方真的能和自己共情，长远来看也未必是什么好事。对于一般人来说，在朋友有病时陪他看病，在平常把他当常人对待才是最理性最负责的做法。专业的问题应该交给专业的人。如果你们想要分享一些实践的心得，我愿意洗耳恭听。如果是想跟我分享自己的创伤故事或者进行一些纯理论层面的抽象辩论甚至只是为了寻找“树洞”，那对不起，我没有兴趣。

弱者有一种操纵别人的手段，就是诱导别人对自己共情，然后突然开始自我伤害，通过虐待自己使别人感到痛苦，以此驱使他人满足自己的需要。这是弱者的一种非常典型的不良人际关系模式，它最终会推开那些有可能帮到他的人，导致他只能沉溺于没完没了的自怨自艾。用伯恩在《人间游戏》里的命名方式，这种操纵手段可以命名为“瞧瞧我多么失败”。

“谁弱谁有理”是互联网文化的特色，但现实世界的逻辑可从来不是这样。**想要自救，唯有自强。**如果无法变强，就应该感恩这个时代为弱者同样提供了一席之地，然后利用这片天地努力发光发热，而不是抱怨命运不公。一个人如果依赖某个关系，就要学会感恩，如果厌恶某个关系，就该学会自强，妄想走第三条路的人只能得精神病。在网络平台上，在关注创伤的人群里，“正常”是十分难得的品质。网上有太多所谓“幸存者”，嘴里说的是创伤，真实动机却见不得人，创伤只是他们操纵别人的工具。有价值的讨论就像沙漠中的甘霖一样稀缺。

Q：为什么你的很多内容讲的是儿童（成人）的心态，举的却是成人（儿童）的例子？

A：我的文章的受众都是成年人。要让成年人体会儿童的心境是需要巧思的。假如你想让一个成年人体会他小时候在不同家具之间来回穿梭的体验，仅仅把他带到小时候生活过的那个环境是不够的。你应该营造一个按照他和他小时候的身材比例等比例放大的空间，里面摆上等比例放大的家具，让他在其中行动起来，他才能够真正找到当年的感觉。我的文章关注的是现象学体验，具体的故事并不重要。

Q：你这里有哪些红线？

A：我不会在外边干涉任何人的自由，但这片空间有独属于它的规矩。

遵纪守法自不必说。人格障碍（譬如边缘性人格障碍、自恋型人格障碍）、重性精神障碍（譬如双相情感障碍、精神分裂症）、物质滥用、神秘主义（譬如宗教和灵修）、身份政治（譬如女性主义、神经多样性、LGBT 及其他各类 DEI 思潮）、结伴互助等在这里都属于禁忌话题。很多创伤人士由于社会化不足，喜欢沉溺于各种貌似深刻实则脱离现实的抽象讨论，完全意识不到隐藏在这些貌似时髦的标签背后危险的一面，以致常常玩火而不自知。请诸君尊重这里的边界，违者拉黑，没有商量余地。

一句话总结：**精神病人勿扰，大聪明勿扰，伸手党勿扰，怂包勿扰，情绪黑洞勿扰。**